

泰合

(6467 TT, NT\$230, 未評等)

重點摘要

1. 泰合以口服膜劑型平台為核心，主力產品 TAH3311 為全球首款 Apixaban（原廠 BMS Eliquis）口服膜，鎖定吞嚥困難的高齡抗凝血病患。美國以 505(b)(2) 途徑申請，PDUFA 目標日為 2027/4/22，將先取得 Tentative Approval；歐洲已於 10M25 送件，預計 2026 年底取證。生產委託德國 LTS 代工，兩條線合計年產能約 5 億片（5mg），每片生產成本不高於 0.5 美元
2. 近期里程碑依序為：BMS 是否提告（45 天期限，公司預期 10M26 下旬揭曉）、紐澳首件授權（公司表示 2026 年內一定簽署），以及歐洲授權（最快 2H26-1H27）。授權採雙軌並行，同時與 BMS 及非原廠洽談，全球已與逾 30 家藥廠簽署保密協定；若與 BMS 合作可提早於美國上市，非原廠路線最差約 11M28 與學名藥同步上市
3. Eliquis 2025 年美國銷售額約 292 億美元、年增約 12%，公司估美國吞嚥困難 AF 患者目標市場約 110-164 億美元。泰合自持藥證與供貨，收益涵蓋簽約金、里程碑金、10-30% 分潤及出廠價與代工成本價差。我們認為，自持藥證使泰合在夥伴選擇與定價上保有主導權，加上定價以原廠為錨、不與學名藥比價，有助於在 2028 年學名藥進入後維持單位獲利

結論

我們認為 TAH3311 已進入取證前的關鍵窗口，美歐法規時程明確，後續評價重估的關鍵在於授權能否落地，而 10M26 下旬 BMS 是否提告將決定美國合作對象與上市時點。我們看好公司以自持藥證、代工價差加分潤建立的「絕對值」收益模式，較一次性簽約金更能反映產品長期銷售潛力；惟紐澳授權已較原規劃延遲、歐洲為避免影響美國定價而放慢節奏，且現有產能僅約美國需求的 1/6。短期首要驗證點為 2026 年內紐澳授權簽署與 BMS 的回應，中期則需觀察擴產資金與時程，以及 FDA 審查團隊更替對審查進度的影響

TAH3311 產品定位與 Eliquis 市場

- TAH3311 為全球首款 Apixaban 口服膜，一天兩片，適應症涵蓋 AF、DVT、PE 及髖膝關節置換術後；泰合自行完成歐美三期並自持藥證
- Eliquis 2025 年美國銷售額約 292 億美元，年增約 12%，公司稱為全球最大小分子藥，同機制第二名約 80 億美元；BMS 1H26 Eliquis 營收年增約 20%（1Q26 約 16%）
- 受 IRA 降價影響，單顆價格由約 8-10 美元降至 3.85 美元，公司認為降價後用藥人數增加，新處方轉向 Eliquis；出血風險 0.66% 是其獨大主因，惟與約 380 種藥物有交互作用

凱基投顧

陳宣甫
886.2.2181.8724
hsuan.chen@kgi.com

徐雋翔
886.2.2181.8745
kenny.ch.hsu@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

吞嚥困難族群與目標市場

- 美國 2025 年 AF 患者約 1,055 萬人，其中 75% 為 65 歲以上，高齡者中 50-75% 有吞嚥困難；公司估 Eliquis 在 AF 的滲透率約三成，美國 AF 患者約四成以上有吞嚥困難
- 主要共病的吞嚥困難比例：中風約 50%、失智症約 68%、帕金森等運動神經疾病約 84%
- 以月藥費 231 美元（一天 3.85 美元）×12 個月計，美國目標市場約 110-164 億美元
- 保險方角度：美國每年約 45 萬名 AF 患者住院，每人約 4.67 萬美元、合計約 211 億美元；相較之下穩定服藥一年約 2,772 美元

法規時程與專利

- 美國以 505(b)(2)申請，PDUFA 目標日 2027/4/22 先取得 Tentative Approval，待訴訟結果再取得 Final Approval；公司以中小企業資格申請，首個產品免申請費（約 240 萬美元）
- 歐洲於 10M25 送件，預計 2026 年底取證
- 專利時程：
 - BMS 美國物質專利 2026/11/21 到期，加計兒童資料 6 個月延至 2027/5/21；劑型專利 2031/4 到期，加 6 個月延至 2031/10
 - 美國以外物質專利 11M26 到期，歐洲將有學名藥進入
 - 美國學名藥和解上市最快 10-11M28，約 4 家
 - 泰合自有專利保護至 2042 年

BMS 訴訟進展

- FDA 受理後 20 天內已通知 BMS，並附非侵權說明與樣品；BMS 有 45 天決定是否提告，公司預期 10M26 下旬揭曉
- 非侵權主要依據為溶出率差異：原廠 30 分鐘溶出率高於特定值，泰合則低於該值
- 前例方面，BMS 與學名藥廠官司約歷時 15-29 個月，與漢達口溶錠案約 7 個月結束；公司認為新劑型案不會拖太久，並視訴訟為談判起點，BMS 若不提告即可直接洽談授權

授權策略與收益模式

- 採雙軌策略，同時洽談 BMS 與非原廠，並依國家獨立授權，先美國以外、再回到美國；全球已與逾 30 家藥廠簽署保密協定。非原廠對象為年營收 10-100 億美元藥廠，且須能達到 Destum 估的 peak 市佔 9%
- 各區進度：
 - 紐澳：首個授權對象年營收約 20-50 億美元，公司表示 2026 年內一定簽署，簽約金不會太大

- 歐洲：最快 2H26-1H27。因美國比價政策，公司擔心歐洲過早低價授權影響美國定價，考慮先自行核價（美國約 3-6 個月、歐洲約 6-9 個月）；德國價格接近美國
- 美國：待 10M26 底 BMS 態度再定。與 BMS 合作無專利問題可提早上市；非原廠路線最快於物質專利到期後上市，最差約 11M28
- BMS 可能以高價切入並逐步替換市場，非原廠則可能以較低價搶市；公司稱 BMS 年營收約 480 億美元，此產品可為其增加約三成營收
- 定價以原廠為錨、不與學名藥比價；原廠轉向直銷後每顆仍可賣 4-5 美元，高於 Medicare 標價 3.85 美元
- 收益看「絕對值」：出廠價與代工成本價差、簽約金、里程碑金及 10-30% 分潤合計；合約通常十年並設銷售門檻，未達可另覓第二家夥伴

代工產能與成本

- 代工廠為德國 LTS，公司稱為全球最大口膜貼片廠，已簽長期合約
- 每批 480 公斤，可切 160 萬片（5mg）或 320 萬片（2.5mg）；一條專屬線年產能約 2.5 億片，另一條同規模線使用率低可調用，合計約 5 億片（5mg）
- 公司估美國需求約 30 億片／年，現有產能約 1/6；擴產僅需補設備，下單至安裝約 6 個月，再跑 3 批並送安定性資料，已查過的廠不需重新查廠；擴充時泰合需分攤部分設備費用
- 每片生產成本不高於 0.5 美元、可能更低；除分潤外，泰合對夥伴的出廠價另有加價。對照原廠毛利率約 80-90%

商業模式與產品線

- 多數產品開發至 Phase 1 後對外授權，由夥伴執行三期與取證，泰合收取簽約金、里程碑金與分潤；Apixaban 因市場規模大，改為自行做到三期並自持藥證，夥伴銷售不佳時可更換
- 長效劑型 TAH3341（一天一片）尚未進入臨床，初步規劃與 TAH3311 一同授權。若 FDA 僅看血中濃度則較簡單，若要求證明較少出血或中風，試驗可能需約 1.5 萬人、3 年；FDA 原審查團隊已全數更換並曾發出補件要求，公司暫不主動對外說明
- 其他產品線：
 - Naloxone 口頰溶膜：鴉片類（如芬太尼）過量急救，約 2-3 分鐘起效
 - Nintedanib 口頰溶膜：特發性肺纖維化，原廠膠囊 BA 約 4.7% 且有嚴重腹瀉，目標將 BA 提高數倍
 - Ondansetron 舌上口膜：化療嘔吐止吐，已於日本取證
 - 另有 ADHD 口服液／貼片（小兒過動症）與 Donepezil 貼片（阿茲海默症）

- CDMO：已為美國兩家藥廠完成劑型開發，第三家進行中；上市後目標建立自有生產線（台灣目前無口服廠）

Factor XIa 競爭

- FXIa 位於凝血路徑較上游，訴求出血風險更低；大分子注射型僅適合高出血風險小眾，不利長期用藥
- Milvexian（BMS、Janssen）於急性冠狀動脈症候群三期失敗；AF三期約 1.55 萬人、以不劣於 Apixaban 為目標，結果預計 2027 年公布。劑量約 100mg，為 Apixaban 5mg 的 20 倍，錠劑更大、更難吞嚥
- 公司認為高價的 FXIa 僅能搶攻高出血風險族群（腸道出血、腎功能不佳、癌症等），短期不影響 TAH3311 定位與 BMS 談判

QA

- 紐澳授權何時簽署？為何延遲？
 - 公司表示 2026 年內一定會簽，但不確定能否在 10/20 前完成
 - 延遲主因為代工合約與授權合約須同時對接：代工廠要求提前 6 個月下單、授權廠商僅願提前 3 個月，另有包裝規格（一盒 30 片或 60 片）、廠區提貨與保險、CMO 印製標籤等細節
 - 首份合約約 70 多頁，後續合約可望加快；藥證尚未取得，簽約早晚影響不大
- 出廠價是否會依核價高低彈性調整？
 - 已洽談的五家均要求比原廠價格低一半，公司會提出 counter offer
 - 評估重點為出廠價、對方售價與分潤合計的絕對值，避免低價破壞行情
- 授權條件與簽約金規模如何考量？
 - 因自有藥證並負責供貨，對方銷售量公司皆能掌握；對方要求半獨家，若要獨家則需更高簽約金
 - 對方可能在簽約金與後續里程碑間取捨；公司偏好長線穩健、使營收最大化，而非追求高簽約金
- 若 BMS 提告，談判與取證是否會延宕？
 - 公司已備妥完整非侵權分析，只需證明 non-infringement，並認為新劑型案時程不會拖太久
- 若不與原廠合作，是否須等官司結束才能銷售？
 - 物質專利 2027/5/21 到期後，夥伴若評估無侵權可自行 at-risk 上市；最差情況約 11M28 與學名藥同時上市
 - 若 BMS 不提告或無合作意願，將馬上轉找其他對象；不論與誰合作，公司希望取證前即有明確授權時程
- 2028 年學名藥進入後價格是否會崩跌？
 - 原廠藥價與美國政策較相關；原廠轉向直銷，每顆仍可賣 4-5 美元，泰合定價以原廠為錨、不與學名藥比

- 長效劑型是否可能與原廠產生訴訟？
 - 長效劑型可涵蓋整個 Apixaban 市場而非僅吞嚥困難族群，公司認為原廠較可能前來洽談授權而非提告
 - 原廠洽談 TAH3311 時亦可能一併考慮 TAH3341

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888 • 傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888 • 傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888 • 傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188 • 傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股(OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有(N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股(U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等(NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
未評等(R)	
*總報酬= (十二個月目標價-現價)/現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，邇後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。